

Datei: eml/2026-07-06_sachstand_nachforderung.eml

Von	Micha Reuter <m.reuter@reuter-haensel.example>
An	Jens Malchow <jens.malchow@example.org>
Datum	Mon, 06 Jul 2026 16:32:00 +0200
Betreff	388/26-R / Klageunterlagen bis 8. Juli

Sehr geehrter Herr Malchow,

die Klagefrist endet am 15. Juli. Bitte senden Sie uns bis 8. Juli den vollständigen Reha-Entlassungsbericht, die Dokumentation der Therapieabbrüche, den aktuellen neurologischen Befund und die Bestätigung des Arbeitgebers zum fehlenden leidensgerechten Arbeitsplatz. Auch der Umschlag des Widerspruchsbescheids gehört in die Akte.

Ihre Hausärztin soll keine pauschale Arbeitsunfähigkeit bestätigen, sondern Gehstrecke, Steh- und Sitzdauer, Sturzereignisse, notwendige Begleitung und Pausen beschreiben. Der Sohn kann für die beiden Stürze Datum, Ort, Wahrnehmung und unmittelbare Folgen in einer eigenen Erklärung festhalten.

Wir reichen die Klage fristwährend ein. Eine abschließende Leistungsbeurteilung formulieren wir erst nach Einsicht in die Verwaltungsakte und Abgleich der Reha-Beobachtungen mit den behandelnden Ärzten.

Mit freundlichen Grüßen

Micha Reuter
Rechtsanwalt
Käthe-Kollwitz-Straße 60 · 04109 Leipzig
Telefon 0341 22591-0

Datei: 10_au_krankengeld_verlauf.csv

zeitraum_von

2024-01-08

zeitraum_bis

2024-02-18

status

arbeitsunfähig

leistung

Entgeltfortzahlung

träger

Arbeitgeber

bemerkung

Beginn AU wegen Lumboischialgie

zeitraum_von

2024-02-15

zeitraum_bis

2024-02-15

status

stationär

leistung

Krankenhausbehandlung

träger

Krankenkasse

bemerkung

Sequestrektomie L5/S1 Auenwaldklinik Leipzig

zeitraum_von

2024-02-19

zeitraum_bis

2025-07-06

status

arbeitsunfähig

leistung

Krankengeld

träger

Krankenkasse

bemerkung

78 Wochen; Aussteuerung zum 06.07.2025

zeitraum_von

2024-09-17

zeitraum_bis

2024-12-11

status

BEM-Verfahren

träger

Arbeitgeber

bemerkung

BEM ohne Ergebnis abgeschlossen

zeitraum_von

2025-07-07

status

arbeitslos gemeldet

leistung

Arbeitslosengeld nach Nahtlosigkeitsregelung

träger

Agentur für Arbeit Leipzig

bemerkung

Vermittlung ruht; Verweis auf Rentenverfahren

zeitraum_von

2025-11-10

status

Rentantrag

träger

DRV Mitteldeutschland

bemerkung

Antrag Erwerbsminderungsrente

zeitraum_von

2026-03-03

zeitraum_bis

2026-03-24

status

stationäre Reha

leistung

Übergangsgeld

träger

DRV Mitteldeutschland

bemerkung

Heilverfahren Bad Lausick

zeitraum_von

2026-04-17

status

Ablehnungsbescheid

träger

DRV Mitteldeutschland

bemerkung

Kennzeichen EM-2025-40317

zeitraum_von

2026-06-12

status

Widerspruchsbescheid

träger

DRV Mitteldeutschland

bemerkung

Zugang 15.06.2026; Klagefrist 15.07.2026

Datei: 91_fristsachen_belege_offene_punkte_2026-07-06.csv

Vorgang	Auslöser	Frist	Vorfrist	Beleg	Status	Nächster Schritt
Klage EM-Rente	Zugang 15.06.2026	2026-07-15	2026-07-08	Widerspruchs bescheid und Umschlag	offen	Klage einreichen
Reha-Therapieabbrüche	März 2026	2026-07-08	2026-07-07	Therapieprotokolle	nur im Bericht erwähnt	Klinikakte anfordern
Neurologie	Polyneuropathie	2026-07-10	2026-07-08	Befund und Gangprüfung	angefordert	Wegefähigkeit konkretisieren
Psychiatrie	depressive Episode	2026-07-10	2026-07-08	Verlaufsbericht	offen	Antrieb und Konzentration
Arbeitgeber	kein Schonarbeitsplatz	2026-07-09	2026-07-08	BEM und Tätigkeitsprofil	angefordert	Bestätigung nachfassen
Zeugenerklärung Sohn	zwei Stürze	2026-07-10	2026-07-08	eigene Wahrnehmung	offen	Datum und Folgen festhalten

Datei

Office-Dokument: 01_mandatsaufnahme.docx

Mandatsaufnahme

Reuter & Hänsel Rechtsanwälte, Käthe-Kollwitz-Straße 60, 04109 Leipzig

Aktenzeichen: 388/26-R

Vermerk des Rechtsanwalts Micha Reuter vom 22.06.2026, Erstgespräch in der Kanzlei

Mandant

Jens Malchow, geboren am 09.09.1971, wohnhaft Dieskaustraße 88, 04229 Leipzig.

Versicherungsnummer: 40 090971 M 003. Gelernter Fachlagerist, seit 2005 bei der Logistikzentrum Sachsenpark GmbH beschäftigt, zuletzt als Schichtleiter Wareneingang in Wechselschicht einschließlich Nachtschicht. Das Arbeitsverhältnis besteht ruhend fort; der Mandant ist seit dem 08.01.2024 durchgehend arbeitsunfähig, wurde am 06.07.2025 aus dem Krankengeld ausgesteuert und bezieht seither Arbeitslosengeld nach der Nahtlosigkeitsregelung.

Gesundheitlicher Verlauf

Seit Januar 2024 bestehen persistierende Schmerzen der Lendenwirbelsäule mit Ausstrahlung in das rechte Bein; die Sequestrektomie L5/S1 am 15.02.2024 brachte nur eine Teilbesserung. Hinzu kommen eine neurologisch gesicherte sensomotorische Polyneuropathie beider Beine bei seit 2019 bekanntem Typ-2-Diabetes sowie eine mittelgradige depressive Episode mit Schlafstörung und Antriebsminderung. Der Mandant schildert, er könne höchstens 20 Minuten stehen, kurze Wege nur mit Pausen bewältigen und verliere bei Taubheitsgefühlen in den Füßen das Gleichgewicht; zwei Stürze in der eigenen Wohnung im Frühjahr 2026 sind hausärztlich dokumentiert. Arztbesuche unternimmt er nur in Begleitung des Sohnes.

Verfahrensstand

Rentenantrag wegen Erwerbsminderung vom 10.11.2025. Die DRV Mitteldeutschland führte zunächst das Heilverfahren im Reha-Zentrum Bad Lausick durch (03.03. bis 24.03.2026). Der Entlassungsbericht sieht ein Leistungsvermögen von sechs Stunden und mehr für leichte, überwiegend sitzende Tätigkeiten, dokumentiert aber mehrere Therapieabbrüche wegen Schwindels, ohne sie in der Leistungsbeurteilung zu verarbeiten. Ablehnungsbescheid vom 17.04.2026; Widerspruch des Mandanten vom 04.05.2026 mit Attest der Hausärztin Dr. Seibt vom 30.04.2026; Nichtabhilfemitteilung vom 28.05.2026; Widerspruchsbescheid vom 12.06.2026, Zugang nach Umschlagvermerk am 15.06.2026.

Der Arbeitgeber hat im Betrieblichen Eingliederungsmanagement 2024 keinen leidensgerechten Arbeitsplatz anbieten können; eine aktuelle Bestätigung mit Tätigkeitsprofil ist angefordert.

Frist

Klagefrist zum Sozialgericht Leipzig: ein Monat ab Bekanntgabe des Widerspruchsbescheids, notiert auf den 15.07.2026; Vorfrist 08.07.2026.

Ziel und Strategie

Klage auf Rente wegen voller, hilfsweise teilweiser Erwerbsminderung. Angriffspunkte: die nicht verarbeiteten Therapieabbrüche, die nur mit Klinikflur und Treppenhaus beschriebene und damit nicht arbeitsmarktbezogene Wegefähigkeit, die fehlende Gesamtwürdigung der Kombination aus orthopädischen, neurologischen und psychischen Einschränkungen sowie die Frage der Summierung ungewöhnlicher Leistungseinschränkungen. Im Klageverfahren sind Befundberichte der behandelnden Ärzte und ein gerichtliches Sachverständigengutachten auf neurologisch-orthopädischem und psychiatrischem Gebiet anzustreben. Kostenprivilegierung nach Paragraph 183 SGG; Deckungszusage der Rechtsschutzversicherung des Mandanten liegt seit dem 24.06.2026 vor.

Datei

Office-Dokument: 02_hausarzt_attest_widerspruch.docx

Hausärztliches Attest zum Widerspruch

Hausarztpraxis Dr. med. Kathrin Seibt, Fachärztin für Allgemeinmedizin

Georg-Schumann-Straße 122, 04155 Leipzig, Telefon 0341 5901-44

Datum: 30.04.2026

Ärztliches Attest zur Vorlage bei der Deutschen Rentenversicherung Mitteldeutschland

Patient: Jens Malchow, geboren am 09.09.1971, Dieskaustraße 88, 04229 Leipzig

Herr Malchow befindet sich seit 2009 in meiner hausärztlichen Behandlung, seit Januar 2024 in engmaschiger Betreuung mit in der Regel zwei Konsultationen monatlich.

Diagnosen: chronisches lumbales Schmerzsyndrom nach Sequestrektomie L5/S1 im Februar 2024 mit pseudoradikulärer und radikulärer Ausstrahlung rechts; sensomotorische Polyneuropathie beider Beine bei Diabetes mellitus Typ 2; mittelgradige depressive Episode; Schlafstörung.

Trotz konsequenter Schmerztherapie und der operativen Versorgung besteht keine belastungsstabile Besserung. Herr Malchow kann nach meiner Beobachtung keine 20 Minuten ununterbrochen stehen, die Gehstrecke ist schmerz- und gangunsicherheitsbedingt auf wenige hundert Meter begrenzt, es kam zu zwei dokumentierten Stürzen (12.03.2026 und 29.04.2026 jeweils häuslich, ohne Fraktur). Aus hausärztlicher Sicht ist eine regelmäßige Erwerbstätigkeit von sechs Stunden täglich, auch in leichter, überwiegend sitzender Ausprägung, gegenwärtig nicht realistisch, weil die Beschwerden wechselhaft sind, die Sitztoleranz eingeschränkt ist und die depressive Symptomatik Ausdauer und Konzentration zusätzlich mindert.

Ich bitte, diese Einschätzung im Widerspruchsverfahren zu berücksichtigen. Für einen ausführlichen Befundbericht mit Medikationsplan und Fremdbefunden stehe ich auf Anforderung zur Verfügung.

Dr. med. Kathrin Seibt

Fachärztin für Allgemeinmedizin

Datei

Office-Dokument: 03_hausarzt_befundbericht.docx

Ausführlicher hausärztlicher Befundbericht

Hausarztpraxis Dr. med. Kathrin Seibt, Fachärztin für Allgemeinmedizin

Georg-Schumann-Straße 122, 04155 Leipzig, Telefon 0341 5901-44

Datum: 11.06.2026

Befundbericht auf Anforderung des Patienten zur Vorlage im sozialgerichtlichen Verfahren

Patient: Jens Malchow, geboren am 09.09.1971

Anamnese und Verlauf

Seit Januar 2024 persistierende Lumboischialgie rechts. Am 15.02.2024 Sequestrektomie L5/S1 in der Auenwaldklinik Leipzig; postoperativ nur teilweise Besserung, seither chronifiziertes Schmerzsyndrom mit belastungsabhängiger Verschlechterung. Parallel progrediente Missempfindungen und Taubheitsgefühle beider Füße; die neurologische Abklärung (Praxis Dr. Behrend, Befund vom 28.04.2026) sicherte eine sensomotorische Polyneuropathie. Seit Herbst 2024 zunehmende depressive Symptomatik mit Antriebsminderung, Grübeln, Durchschlafstörung; eine ambulante Psychotherapie ist seit Februar 2026 beantragt, ein Therapieplatz steht aus.

Aktueller Befund

Kraftgrad der Fußheber rechts 4/5, abgeschwächter Achillessehnenreflex beidseits, Pallhypästhesie beider Großzehen und Malleolen, unsicheres Gangbild mit verkürzter Schrittlänge, Romberg-Stehversuch unsicher. Finger-Boden-Abstand 38 cm, deutlicher Hartspann lumbal. Psychisch: gedrückte Stimmung, reduzierter Antrieb, Klagsamkeit ohne Aggravationszeichen.

Medikation

Pregabalin 150 mg zweimal täglich, Metamizol bei Bedarf, Tilidin/Naloxon retard 100/8 mg zweimal täglich, Metformin 1000 mg zweimal täglich, Mirtazapin 30 mg zur Nacht.

Leistungsbeurteilung aus hausärztlicher Sicht

Die Belastbarkeit schwankt von Tag zu Tag erheblich. Die sichere Gehstrecke schätze ich anhand der Schilderungen und der Vorstellungen in der Praxis auf 80 bis 120 Meter am Stück; danach benötigt der Patient eine Pause. Längeres Sitzen ist nach 30 bis 40 Minuten schmerzbedingt zu unterbrechen. Schon Arztbesuche werden vom Sohn begleitet, weil der Patient sich Wege in unbekannter Umgebung nicht mehr zutraut und zweimal gestürzt ist. Eine regelmäßige Tätigkeit unter den Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarkts ist aus meiner Sicht derzeit auch für leichte Tätigkeiten nicht in einem Umfang von sechs Stunden täglich möglich. Ich verkenne nicht, dass die sozialmedizinische Beurteilung dem Rentenversicherungsträger und gegebenenfalls dem Gericht obliegt; die vorstehende Einschätzung beruht auf dem Langzeitverlauf seit 2024.

Dr. med. Kathrin Seibt

Fachärztin für Allgemeinmedizin

Datei

Office-Dokument: 04_neurologischer_befundbericht.docx

Neurologischer Befundbericht

Praxis für Neurologie Dr. med. Frank Behrend

Karl-Liebknecht-Straße 30, 04107 Leipzig, Telefon 0341 2254-70

Datum: 28.04.2026

Befundbericht an die Hausarztpraxis Dr. Seibt, nachrichtlich dem Patienten ausgehändigt

Patient: Jens Malchow, geboren am 09.09.1971

Fragestellung

Abklärung sensomotorischer Störungen beider Beine, Gangunsicherheit, Stürze.

Elektrophysiologie vom 28.04.2026

Nervenleitgeschwindigkeit Nervus suralis beidseits deutlich reduziert (rechts 32 m/s, links 34 m/s), Amplituden erniedrigt. Nervus peroneus rechts: motorische Nervenleitgeschwindigkeit 36 m/s, verlängerte distale Latenz. Elektromyographisch chronisch-neurogene Veränderungen der kleinen Fußmuskulatur beidseits.

Klinischer Befund

Socken- und handschuhförmig betonte Hypästhesie und Pallhypästhesie (Stimmgabel 3/8 an beiden Großzehen, 4/8 an den Malleolen), abgeschwächte Achillessehnenreflexe beidseits, Fußheberschwäche rechts Kraftgrad 4/5, unsicherer Seiltänzerengang, Blindgang nicht durchführbar. Zusätzlich radikuläre Residualsymptomatik S1 rechts nach Sequestrektomie 02/2024.

Beurteilung

Gesicherte sensomotorische, vorwiegend axonale Polyneuropathie beider Beine, am ehesten diabetischer Genese, mit relevanter Stand- und Gangunsicherheit. In Kombination mit der lumbalen Residualsymptomatik besteht eine erhöhte Sturzgefahr, insbesondere auf unebenem Boden, auf Leitern und bei Dunkelheit. Tätigkeiten mit Steh- und Gehanteilen, Absturzgefahr oder Anforderungen an die Feinmotorik der Füße (Pedalbedienung) sind aus neurologischer Sicht nicht mehr leistungsgerecht. Die Frage der zumutbaren täglichen Arbeitszeit ist sozialmedizinisch zu beurteilen; aus rein neurologischer Sicht limitieren vor allem die Gangunsicherheit und die schmerzbedingt reduzierte Ausdauer.

Wiedervorstellung zur Verlaufskontrolle in sechs Monaten empfohlen; eine Optimierung der Diabeteseinstellung wurde mit dem Patienten besprochen.

Dr. med. Frank Behrend

Facharzt für Neurologie

Datei

Office-Dokument: 05_reha_entlassungsbericht_auszug.docx

Reha-Entlassungsbericht (Auszug)

Reha-Zentrum Bad Lausick, Klinik für Orthopädie und Psychosomatik, Parkstraße 2, 04651 Bad Lausick

Entlassungsbericht vom 31.03.2026 an die Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland

Rehabilitand: Jens Malchow, geboren am 09.09.1971, Versicherungsnummer 40 090971 M 003

Aufenthalt: 03.03.2026 bis 24.03.2026 (stationäres Heilverfahren)

Diagnosen

1. Chronisches LWS-Syndrom bei Zustand nach Sequestrektomie L5/S1 (02/2024) mit radikulärer Residualsymptomatik S1 rechts
2. **Sensomotorische Polyneuropathie beider Beine**
3. Mittelgradige depressive Episode
4. Diabetes mellitus Typ 2

Reha-Verlauf

Der Rehabilitand nahm an Krankengymnastik, Rückenschule, medizinischer Trainingstherapie, Ergotherapie und psychologischen Einzel- und Gruppengesprächen teil. Die Trainingsintensität konnte nur langsam gesteigert werden. Dokumentiert sind vier vorzeitige Abbrüche von Therapieeinheiten (09.03., 12.03., 17.03. und 20.03.2026), jeweils wegen angegebenen Schwindels mit Gangunsicherheit; am 17.03.2026 musste der Rehabilitand von einem Therapeuten zum Zimmer begleitet werden. Eine weiterführende internistisch-neurologische Abklärung des Schwindels erfolgte während des Aufenthalts nicht. Die psychologischen Gespräche ergaben eine gedrückte Grundstimmung mit Insuffizienzerleben; eine ambulante Psychotherapie wurde empfohlen.

Sozialmedizinische Leistungsbeurteilung

Letzte berufliche Tätigkeit als Schichtleiter Wareneingang (Heben und Tragen bis 25 kg, überwiegend Stehen und Gehen, Wechselschicht): nur noch unter drei Stunden täglich möglich.

Leichte körperliche Tätigkeiten des allgemeinen Arbeitsmarkts: sechs Stunden und mehr täglich möglich, überwiegend im Sitzen, ohne Zwangshaltungen, ohne Heben und Tragen von Lasten über fünf Kilogramm, ohne Leitern und Gerüste, ohne Nachtschicht, ohne besonderen Zeitdruck.

Die Wegefähigkeit wurde im Klinikbereich beobachtet: Der Rehabilitand bewältigte den Klinikflur (etwa 60 Meter) und das Treppenhaus über eine Etage am Handlauf selbständig. Weitergehende Gehstreckentestungen im Außengelände sind nicht dokumentiert.

Entlassung

Entlassung als arbeitsunfähig für die letzte Tätigkeit. Nahtlosigkeit der sozialen Sicherung wurde mit dem Sozialdienst besprochen. Empfohlen werden ambulante Psychotherapie, Fortführung der Schmerztherapie und Optimierung der Diabeteseinstellung.

Datei

Office-Dokument: 06_drv_ablehnungsbescheid.docx

Ablehnungsbescheid der DRV Mitteldeutschland

Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland, Georg-Schumann-Straße 146, 04159 Leipzig

Versicherungsnummer: 40 090971 M 003

Kennzeichen: EM-2025-40317

Datum: 17.04.2026

Herrn

Jens Malchow

Dieskaustraße 88

04229 Leipzig

Betreff: Ihr Antrag vom 10.11.2025 auf Rente wegen Erwerbsminderung

Sehr geehrter Herr Malchow,

Ihr Antrag auf Rente wegen Erwerbsminderung wird abgelehnt.

Begründung

Anspruch auf Rente wegen voller oder teilweiser Erwerbsminderung besteht nur, wenn das Leistungsvermögen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt auf unter drei beziehungsweise unter sechs Stunden täglich gesunken ist. Das ist bei Ihnen nicht der Fall.

Nach dem Entlassungsbericht des Reha-Zentrums Bad Lausick vom 31.03.2026 über das vom 03.03.2026 bis 24.03.2026 durchgeführte Heilverfahren können Sie leichte körperliche Tätigkeiten, überwiegend im Sitzen, ohne Zwangshaltungen, ohne Heben und Tragen von Lasten über fünf Kilogramm, ohne Leitern und Gerüste und ohne Nachtschicht noch mindestens sechs Stunden täglich unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarkts verrichten. Die festgestellten Gesundheitsstörungen (Wirbelsäulenleiden nach Operation, Polyneuropathie, depressive Episode, Diabetes mellitus) schließen schwere körperliche Arbeit und Ihre letzte Tätigkeit als Schichtleiter im Wareneingang aus, nicht aber leichte Tätigkeiten im genannten Umfang. Ob Ihnen ein entsprechender Arbeitsplatz vermittelt werden kann, ist für den Rentenanspruch ohne Bedeutung; das Risiko der Arbeitsvermittlung trägt die Arbeitslosenversicherung.

Auch eine Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung bei Berufsunfähigkeit kommt nicht in Betracht, weil Sie nach dem 01.01.1961 geboren sind.

Die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen (allgemeine Wartezeit, Pflichtbeiträge in den letzten fünf Jahren) wären im Übrigen erfüllt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Deutschen Rentenversicherung Mitteldeutschland, Georg-Schumann-Straße 146, 04159 Leipzig, einzulegen.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Teschner

Datei

Office-Dokument: 07_widerspruch_mandant.docx

Widerspruch des Mandanten

Jens Malchow, Dieskaustraße 88, 04229 Leipzig

Versicherungsnummer: 40 090971 M 003

Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland

Georg-Schumann-Straße 146

04159 Leipzig

Datum: 04.05.2026

Betreff: Widerspruch gegen den Bescheid vom 17.04.2026, Kennzeichen EM-2025-40317

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen Ihren Bescheid vom 17.04.2026, mit dem Sie meinen Antrag auf Erwerbsminderungsrente abgelehnt haben, lege ich Widerspruch ein.

Der Reha-Bericht, auf den Sie sich stützen, gibt meinen Zustand nicht richtig wieder. In der Reha musste ich viermal Anwendungen abbrechen, weil mir schwindlig wurde und ich Angst hatte zu stürzen; einmal musste mich ein Therapeut aufs Zimmer bringen. Das steht zwar im Bericht, aber bei der Einschätzung am Ende kommt es nicht mehr vor. Dass ich sechs Stunden sitzen und arbeiten könnte, hat mit meinem Alltag nichts zu tun: Ich kann keine 20 Minuten stehen, nach einer halben Stunde Sitzen muss ich aufstehen und umhergehen, und wegen der tauben Füße bin ich zu Hause schon zweimal gestürzt. Zum Arzt begleitet mich mein Sohn, weil ich mich alleine nicht mehr traue.

Wie ich unter diesen Umständen jeden Tag zu einer Arbeitsstelle kommen soll, beantwortet der Bericht auch nicht; getestet wurde nur der Flur in der Klinik.

Ich füge ein Attest meiner Hausärztin Dr. Seibt vom 30.04.2026 bei und bitte Sie, meinen Antrag noch einmal gründlich zu prüfen und dabei auch meine Nervenkrankheit und die Depression zusammen zu bewerten und nicht jede Krankheit einzeln.

Mit freundlichen Grüßen

Jens Malchow

Anlage: Ärztliches Attest Dr. med. Seibt vom 30.04.2026

Datei

Office-Dokument: 08_widerspruchsbescheid.docx

Widerspruchsbescheid

Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland, Widerspruchsstelle, Georg-Schumann-Straße 146,
04159 Leipzig

Versicherungsnummer: 40 090971 M 003

Kennzeichen: EM-2025-40317/W

Datum: 12.06.2026

Herrn

Jens Malchow

Dieskaustraße 88

04229 Leipzig

Betreff: Ihr Widerspruch vom 04.05.2026 gegen den Bescheid vom 17.04.2026

Sehr geehrter Herr Malchow,

die Widerspruchsstelle hat am 09.06.2026 über Ihren Widerspruch entschieden:

Der Widerspruch wird zurückgewiesen.

Begründung

Der angefochtene Bescheid ist nicht zu beanstanden. Grundlage der Entscheidung ist der zeitnah zum Rentenantrag erstellte Entlassungsbericht des Reha-Zentrums Bad Lausick vom 31.03.2026, der auf einer dreiwöchigen stationären Beobachtung beruht und in sich schlüssig ist. Danach besteht für leichte, überwiegend sitzende Tätigkeiten ein Leistungsvermögen von sechs Stunden und mehr täglich.

Das im Widerspruchsverfahren vorgelegte hausärztliche Attest vom 30.04.2026 führt zu keiner anderen Beurteilung. Es enthält keine sozialmedizinische Leistungsbeurteilung nach den Maßstäben der gesetzlichen Rentenversicherung, sondern gibt im Wesentlichen die Beschwerdeschilderung des Patienten wieder. Die vorgetragenen Therapieunterbrechungen während des Heilverfahrens sind im Entlassungsbericht dokumentiert und von den Ärzten der Rehabilitationseinrichtung bei der abschließenden Beurteilung gewürdigt worden. Anhaltspunkte für eine rentenrechtlich relevante Einschränkung der Wegefähigkeit ergeben sich aus dem Bericht nicht; danach konnten Sie sich im Klinikbereich einschließlich Treppen selbständig bewegen. Eine Summierung ungewöhnlicher Leistungseinschränkungen liegt nicht vor, weil die qualitativen Einschränkungen das Feld leichter Tätigkeiten nicht wesentlich verengen.

Die Kosten des Widerspruchsverfahrens werden nicht erstattet.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Widerspruchsbescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Sozialgericht Leipzig, Bernhard-Göring-Straße 64, 04275 Leipzig, erheben. Die Klage ist schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erheben.

Im Auftrag

Dr. Wollank

Leiterin der Widerspruchsstelle

Vermerk auf dem Umschlag (handschriftlich, Mandant): "Lag am 15.06.2026 im Briefkasten."

Datei

Office-Dokument: 09_arbeitgeberbescheinigung_taetigkeit.docx

Arbeitgeberbescheinigung zum Tätigkeitsprofil

Logistikzentrum Sachsenpark GmbH, Am alten Flughafen 10, 04356 Leipzig

Personalnummer: 2005-0331

Datum: 25.06.2026

Reuter & Hänsel Rechtsanwälte

Käthe-Kollwitz-Straße 60

04109 Leipzig

Betreff: Herr Jens Malchow – Tätigkeitsprofil und betriebliches Eingliederungsmanagement

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Ihre Anfrage vom 23.06.2026 bestätigen wir für unseren Mitarbeiter Herrn Jens Malchow, beschäftigt seit dem 01.04.2005, zuletzt als Schichtleiter Wareneingang:

Tätigkeitsprofil Schichtleiter Wareneingang

Die Tätigkeit umfasst die Annahme und Kontrolle eingehender Waren, die Führung eines Teams von acht bis zwölf Lagerkräften je Schicht, die Bedienung von Handhubwagen und Scannerarbeitsplätzen sowie die Bearbeitung von Reklamationen an Stehpulten. Der Steh- und Gehanteil beträgt nach der Gefährdungsbeurteilung etwa 80 Prozent der Arbeitszeit. Regelmäßig fallen das Heben und Tragen von Packstücken bis 25 Kilogramm sowie das Besteigen von Anlegeleitern an Regalen an. Gearbeitet wird in drei Schichten einschließlich Nachtschicht; die Schichtleitung kann nicht dauerhaft aus der Nachtschicht herausgenommen werden, weil die Leitungsfunktion an die Schicht gebunden ist.

Betriebliches Eingliederungsmanagement

Herr Malchow ist seit dem 08.01.2024 durchgehend arbeitsunfähig. Ein betriebliches Eingliederungsmanagement wurde am 17.09.2024 begonnen und am 11.12.2024 ohne Ergebnis abgeschlossen. Geprüft wurden eine Umsetzung an den Leitstand (abgelehnt, weil der Leitstandsplatz mit ständiger Vertretungspflicht in der Halle verbunden ist), eine reine Büroverwendung in der Disposition (keine freie Stelle, Anforderungsprofil kaufmännische Ausbildung) und eine stundenweise Wiedereingliederung (von den behandelnden Ärzten seinerzeit nicht befürwortet). Ein leidensgerechter Arbeitsplatz, der überwiegend sitzende Tätigkeit ohne Heben über fünf Kilogramm und ohne Schichtbindung ermöglicht, besteht in unserem Betrieb nicht.

Das Arbeitsverhältnis besteht ruhend fort. Eine krankheitsbedingte Kündigung ist derzeit nicht beabsichtigt.

Mit freundlichen Grüßen

Heike Brandis

Leiterin Personal

Telefon: 0341 52488-12

Datei

Office-Dokument: 11_klageentwurf.docx

Klageentwurf

Reuter & Hänsel Rechtsanwälte, Käthe-Kollwitz-Straße 60, 04109 Leipzig

Unser Zeichen: 388/26-R

Entwurfsstand: 30.06.2026 (zur Einreichung bis 08.07.2026 vorgesehen)

An das

Sozialgericht Leipzig

Bernhard-Göring-Straße 64

04275 Leipzig

Klage

des Herrn Jens Malchow, Dieskaustraße 88, 04229 Leipzig,

– Kläger –

Prozessbevollmächtigte: Reuter & Hänsel Rechtsanwälte, Käthe-Kollwitz-Straße 60, 04109 Leipzig,
gegen

die Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland, Georg-Schumann-Straße 146, 04159 Leipzig,

– Beklagte –

wegen Rente wegen Erwerbsminderung.

Namens und in Vollmacht des Klägers erheben wir Klage und beantragen,

1. den Bescheid der Beklagten vom 17.04.2026 in der Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 12.06.2026 aufzuheben,
2. die Beklagte zu verurteilen, dem Kläger ab dem 01.11.2025 Rente wegen voller Erwerbsminderung, hilfsweise Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung, in gesetzlicher Höhe zu gewähren.

Begründung:

Der Kläger, geboren am 09.09.1971, war zuletzt Schichtleiter Wareneingang und ist seit dem 08.01.2024 durchgehend arbeitsunfähig. Er leidet an einem chronifizierten Schmerzsyndrom der Lendenwirbelsäule nach Sequestrektomie L5/S1, an einer neurologisch gesicherten sensomotorischen Polyneuropathie beider Beine mit Stand- und Gangunsicherheit sowie an einer mittelgradigen depressiven Episode.

Die Beklagte stützt ihre Ablehnung allein auf den Entlassungsbericht des Reha-Zentrums Bad Lausick vom 31.03.2026. Dieser trägt die Leistungsbeurteilung nicht. Der Bericht dokumentiert vier Abbrüche von Therapieeinheiten wegen Schwindels mit Gangunsicherheit, verhält sich in der sozialmedizinischen Beurteilung hierzu aber mit keinem Wort; die im Widerspruchsbescheid behauptete Würdigung findet im Bericht selbst nicht statt. Die Wegefähigkeit ist ausschließlich mit Klinikflur und Treppenhaus beschrieben worden; eine Aussage über das Zurücklegen von viermal mehr als 500 Metern täglich in jeweils zumutbarer Zeit und die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel lässt sich daraus nicht gewinnen. Schließlich fehlt eine Gesamtwürdigung des Zusammenwirkens der orthopädischen, neurologischen und psychischen Gesundheitsstörungen einschließlich der Frage einer Summierung ungewöhnlicher Leistungseinschränkungen.

Zum Beweis der eingeschränkten Leistungsfähigkeit beziehen wir uns auf die beigelegten Unterlagen (hausärztliches Attest vom 30.04.2026, ausführlicher Befundbericht vom 11.06.2026, neurologischer Befundbericht vom 28.04.2026, Arbeitgeberbescheinigung vom 25.06.2026) und regen an, Befundberichte der behandelnden Ärzte einzuholen. Wir beantragen ferner, ein Sachverständigengutachten auf neurologisch-orthopädischem und auf psychiatrischem Fachgebiet einzuholen, das sich insbesondere zur quantitativen Leistungsfähigkeit, zur Wegefähigkeit und zum Zusammenwirken der Gesundheitsstörungen verhält.

Der Widerspruchsbescheid ist dem Kläger am 15.06.2026 zugegangen; die Klage ist fristgerecht.

Das Verfahren ist für den Kläger gerichtskostenfrei.

Reuter

Rechtsanwalt

Anlagen: Bescheid vom 17.04.2026; Widerspruchsbescheid vom 12.06.2026; Attest Dr. Seibt vom 30.04.2026; Befundbericht Dr. Seibt vom 11.06.2026; Befundbericht Dr. Behrend vom 28.04.2026; Arbeitgeberbescheinigung vom 25.06.2026; Vollmacht